

Gastroözofageal Reflü ve GÖRH

Bebek regürjitasyonu (fizyolojik reflü) ile gastroözofageal reflü hastalığının (GÖRH) ayırımı, kanıta dayalı basamaklı yaklaşım ve dozlu tedavi. NASPGHAN/ESPGHAN 2018 ve Rome IV temelli.

NASPGHAN/ESPGHAN 2018

Rome IV

İnek sütü eliminasyonu

PPI/H2 dozları

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Reflü (GÖR), mide içeriğinin özofagusa geri kaçması olup süt çocuğunda büyük ölçüde fizyolojiktir. GÖRH ise reflünün rahatsız edici semptom ve/veya komplikasyonlara yol açtığı durumdur. Süt çocuğunda ilk basamak tanı klinikttir; testler tanıyı doğrulamaktan çok komplikasyonu ve ayırıcı tanıyı dışlamak içindir.

GÖR = fizyolojik olay

GÖRH = rahatsız edici semptom/komplikasyon

Ampirik PPI süt çocuğunda tanı testi DEĞİL

Öykü

- Başlangıç yaşı, sıklık ve regürjitasyon/kusma paterni; içeriğin niteliği (safralı, kanlı, fışkırır tarzda).
- Beslenme öyküsü: hacim (aşırı beslenme?), sıklık, formül tipi, hazırlama hatası, anne sütü/inek sütü maruziyeti.
- Büyüme eğrisi trendi; tartı alımı ve persentil kaymaları.
- Eşlik eden bulgular: huzursuzluk/ağlama, beslenme reddi, yay tarzı postür (Sandifer), öksürük/hışıltı, apne-BRUE.
- Atopi/inek sütü proteini alerjisi (İSPA) ipuçları: egzama, kanlı-mukuslu dışkı, ailede atopi.
- Kırmızı bayrak taraması ve ilaç/toksin öyküsü.

Muayene

- Antropometri: kilo, boy, baş çevresi persentilleri ve zamansal eğri (büyüme geriliği erken alarm).
- Genel durum, hidrasyon, dismorfik/nörolojik bulgular (nörogelişimsel bozuklukta GÖRH riski yüksek).
- Karın muayenesi: distansiyon, kitle, organomegali, pilor kitlesi (zeytin) palpasyonu.
- Solunum: stridor, hışıltı, tekrarlayan aspirasyon işaretleri.
- Cilt: atopik dermatit; nörolojik: tonus, fontanel (KİBAS).
- ORL/dental: erozyon, tekrarlayan otit (ekstraözofageal bulgular).

Rome IV — Süt çocuğu regürjitasyonu: 3 hafta – 12 ay arası sağlıklı bebekte, günde ≥ 2 kez, ≥ 3 haftadır regürjitasyon; öğürme, hematemez, aspirasyon, apne, büyüme geriliği, beslenme/yutma güçlüğü veya anormal postür YOK. Bu ölçütler karşılanıyorsa tanı klinik olup ileri tetkik ve ilaç gereksizdir.

Baskın mekanizma geçici alt özofagus sfinkteri gevşemeleridir (TLESR). Süt çocuğunda kısa intraabdominal özofagus, sık ve yüksek hacimli sıvı beslenme, yatar pozisyon ve gelişimsel olgunlaşmamışlık zemini kolaylaştırır.

Antireflü bariyer

- Geçici AÖS gevşemeleri (TLESR) — ana mekanizma.
- Kısa/karın-içi segmenti az özofagus, His açısı olgunlaşmamışlığı.

Beslenme yükü

- Yüksek hacim/kg ve sık öğün; aşırı beslenme.
- Tamamı sıvı diyet, yatar pozisyonda beslenme.

Klirens/boşalma

- Özofageal peristaltik klirens yetersizliği.
- Gecikmiş mide boşalması.

İSPA örtüşmesi

- İnek sütü proteini alerjisi, dirençli regürjitasyon/huzursuzluğu taklit eder ve şiddetlendirir.
- 2-4 haftalık eliminasyon denemesi ayıricıdır.

Yüksek riskli gruplar

- Nörolojik bozukluk, özofagus atrezisi onarımı, hiatal herni.
- Prematürite, kistik fibrozis, obezite (adölesan).

Doğal seyir

- Regürjitasyon 6. ayda zirve, %90'ı 12. ayda kaybolur.
- Kalıcı/kötüleşen seyir GÖRH veya alternatif tanı lehine.

03 Karar akışı

Kırmızı bayrak yoksa ve büyüme normale mutlu regürjite eden bebekte yaklaşım ebeveyn eğitimi ve yaşam tarzı önlemleridir; farmakoterapi ampirik olarak başlanmaz.

BAŞLANGIÇ

Regürjitasyon / kusma ile başvuru

Öykü, muayene, büyüme eğrisi ve kırmızı bayrak taraması.

ADIM 1

Kırmızı bayrak değerlendirmesi

Safıralı/kanlı kusma, büyüme geriliği, nörolojik bulgu, geç başlangıç (>6 ay) veya alarm için tarama.

KARAR 1

Kırmızı bayrak var mı?

Herhangi bir alarm bulgusu mevcut mu?

EVET → Fizyolojik değil

HAYIR → Büyüme normal, mutlu regürjite eden

ALARM

Hedefe yönelik tetkik

Ayırıcı tanıya göre USG/üst GİS grafisi, endoskopi, metabolik/nörolojik değerlendirme; ampirik antisekretuar başlama.

ADIM 2

Ebeveyn eğitimi + yaşam tarzı

Güvence, öğün hacim/sıklık düzenleme, kıvamlaştırma; sırtüstü uyku korunur. 2-4 hafta izle.

KARAR 2

Yaşam tarzı önlemleriyle yanıt yeterli mi?

Semptom/huzursuzluk sürüyor mu, İSPA ipuçları var mı?

HAYIR → Dirençli, İSPA olası

EVET → İyileşme

ADIM 3

İnek sütü eliminasyon denemesi

2-4 hafta: anne sütünde annede inek sütü eliminasyonu; formülde geniş hidrolizat. Yanıt varsa İSPA; yoksa GÖRH lehine ilerle.

İZLEM

Doğal seyir beklentisi

12. aya dek spontan gerileme; ebeveyn güvencesi ve büyüme takibi yeterli.

KARAR 3

Belirgin GÖRH kanıtı / dirençli semptom?

Özofajit düşündüren bulgu, kilo kaybı, ekstraözofageal hastalık veya tanı belirsizliği var mı?

EVET → GÖRH yönetimi

HAYIR → Fonksiyonel

ADIM 4

Antisekretuar deneme + endoskopi/pH-empedans planı

4-8 hafta PPI; yanıtızlık, tanı belirsizliği veya cerrahi öncesi değeriendirmede üst GİS endoskopisi ve/veya pH-empedans.

SONLANIM

Konservatif izlem

Gereksiz ilaç ve tetkikten kaçın; ebeveyn eğitimi ve büyüme takibi.

Anahtar ilke: Rahatsız edici semptomu olmayan mutlu regürjite eden bebekte kıvamlılaştırma dışında müdahale gerekmez; asit baskılama ampirik tanı aracı olarak kullanılmaz.

Testler seçici kullanılır: GÖRH için altın standart tek bir test yoktur. Endoskopi mukozal hasarı ve ayırıcı tanıyı (eozinofilik özofajit) gösterir; pH-empedans reflü yükünü ve semptom ilişkisini niceler.

GÖRH'te basamaklı tanısal yaklaşım ve endikasyonlar		
BASAMAK / TEST	NE ZAMAN	AMAÇ VE NOT
Klinik değerlendirme	Tüm olgular	Öykü + muayene + büyüme eğrisi; Rome IV ile fizyolojik regürjitasyon tanısı klinik konur.
İnek sütü eliminasyon denemesi	2-4 hafta	Dirençli regürjitasyon/huzursuzluk + İSPA ipucunda tanısal-terapötik deneme; yanıt sonrası reintrodüksiyon ile doğrula.
Ampirik PPI denemesi	Çocuk/adölesan: 4-8 hafta	Tipik semptomlu daha büyük çocukta makul; süt çocuğunda tanı testi olarak ÖNERİLMEZ.
Üst GiS grafisi (baryumlu)	Anatomik şüphe	Malrotasyon, darlık, hiatal herni, akalazya ayırımı için; GÖRH tanısı için uygun değildir (yüksek yanlış +/-).
Üst GiS endoskopisi + biyopsi	Alarm / yanıtsızlık	Erozif özofajit, Barrett, darlık ve eozinofilik özofajit dışlanması; normal endoskopi GÖRH'ü dışlamaz.

BASAMAK / TEST	NE ZAMAN	AMAÇ VE NOT
pH-empedans (MII-pH) 24 saat	Seçilmiş olgular	Asidik + non-asidik reflü yükü ve semptom ilişkisi; antisekretuar yanıtıslığı, ekstraözofageal semptom, fundoplikasyon öncesi/sonrası.
Yalnız pH-metri	Sınırlı	Asit maruziyet indeksi ve ilaç etkinliğı; non-asidik reflüyü kaçırır, empedans yoksa kullanılır.
Mide boşalma sintigrafisi / manometri	Özel durumlar	Rutin değil; boşalma bozukluğu veya motilite hastalığı şüphesinde seçici.

pH-empedans + endoskopi kombinasyonu, ilaca dirençli veya atipik/ekstraözofageal semptomlu olguda tanısal getirisi en yüksek yaklaşımdır.

Aşağıdaki bulgular basit regürjitasyondan uzaklaştırır ve derhal hedefe yönelik tetkik gerektirir.

- Safralı kusma (obstrüksiyon) veya hematemez/melena.

- Fıskırır tarzda inatçı kusma (pilor stenozu).

- Büyüme geriliği, kilo kaybı veya beslenme reddi.

- Kusmanın 6 aydan sonra başlaması veya 12-18 aydan sonra sürmesi.

- Ateş, letarji, hepatosplenomegali, kabarık fontanel (KİBAS/enfeksiyon).

- Nöbet, makro/mikrosefali, gelişimsel gerileme.

- Karın distansiyonu, hassasiyet, palpe edilen kitle.

- Kronik ishal, kanlı-mukuslu dışkı (İSPA/enterokolit).

- Apne, BRUE, tekrarlayan aspirasyon pnömonisi.

- Disüri/İYE, metabolik hastalık şüphesi.

Herhangi bir kırmızı bayrak varlığında yaklaşım fizyolojik reflü değildir; ayırıcı tanıya göre görüntüleme/endoskopi ve gerekli laboratuvar hemen planlanır.

06 Tedavi — dozlu

Basamak: (1) ebeveyn eğitimi ve yaşam tarzı, (2) kıvamlaştırma, (3) 2-4 hafta inek sütü eliminasyonu, (4) seçilmiş GÖRH olgularında 4-8 hafta antisekretuar. PPI, H2RA'ya üstündür; kronik/gereksiz kullanımdan kaçınılır ve en kısa etkili sürede kesilir.

1. Yaşam tarzı

2. Kıvamlaştırma

3. İSPA eliminasyonu 2-4 hf

4. PPI 4-8 hf

Prokinetik rutin DEĞİL

Farmakolojik ve non-farmakolojik tedavi — doz ve maksimumlar

AJAN / ÖNLEM	DOZ (MG/KG + MAKSİMUM)
Öğün düzenleme / kıvamlaştırma	Hacim ~kg başına düzenle; keçiyoynuzu/pirinç nişastası ile k
Geniş hidrolizat / aminoasit formül	2-4 hafta deneme
Omeprazol (PPI)	1-2 mg/kg/gün, tek doz (maks 20-40 mg/gün)
Esomeprazol (PPI)	10 mg (<20 kg) / 20 mg (≥20 kg) günde bir (maks 40 mg)
Lansoprazol (PPI)	1-2 mg/kg/gün (≤30 kg: 15 mg; >30 kg: 30 mg; maks 30 mg)
Famotidin (H2RA)	0.5-1 mg/kg/doz, günde 2 (maks 40 mg/doz)
Aljinat (sodyum/magnezyum aljinat)	Yaşa göre standart doz, öğün sonrası
Antasitler / prokinetikler	Rutin önerilmez

AJAN / ÖNLEM	DOZ (MG/KG + MAKSİMUM)
Nissen fundoplikasyon	Cerrahi — seçilmiş olgu

PPI denemesi 4-8 hafta ile sınırlandırılır; yanıt varsa kademeli azaltılarak kesilir, yanıt yoksa tanı yeniden değerlendirilir (endoskopi/pH-empedans, eozinofilik özofajit dışlaması). Süt çocuğunda uzun süreli PPI enfeksiyon ve kemik riski nedeniyle endikasyonla sınırlıdır.

Amaç: fizyolojik regürjitasyonda gereksiz ilaç/tetkiği önlemek, GÖRH'te ise komplikasyonları erken yakalamak ve tedaviyi zamanında sonlandırmak.

Fizyolojik regürjitasyon izlemi

- Ebeveyn eğitimi ve güvence; doğal seyir (12. ayda gerileme) anlatılır.
- 2-4 haftalık aralıkla büyüme eğrisi takibi.
- Yeni kırmızı bayrak çıkışında yeniden değerlendirme.
- İlaç başlanmaz; kıvamlaştırma ile semptomatik rahatlatma yeterli.

GÖRH izlemi

- PPI yanıtını 4-8 haftada değerlendir; yanıt varsa kademeli kes.
- Yanıtsızlıkta uyum/doz zamanlaması kontrolü, ardından endoskopi/pH-empedans.
- Erozif özofajitte iyileşmeyi endoskopik doğrula; darlıkta dilatasyon planı.
- Yüksek riskli grupta (nörolojik bozukluk, EA onarımı) uzun dönem izlem ve cerrahi değerlendirme.

Basamaklardan geri çekilme kuralı: semptomlar kontrol altına alındığında asit baskılama en kısa etkili sürede sonlandırılır; kronik tedavi ancak objektif GÖRH kanıtı ve komplikasyon varlığında sürdürülür.

Kaynaklar

1. Rosen R, Vandenplas Y, Singendonk M, ve ark. Pediatric Gastroesophageal Reflux Clinical Practice Guidelines: Joint Recommendations of NASPGHAN and ESPGHAN. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2018;66(3):516-554.
2. Benninga MA, Nurko S, Faure C, ve ark. Childhood Functional Gastrointestinal Disorders: Neonate/Toddler (Rome IV). Gastroenterology. 2016;150(6):1443-1455.
3. Vandenplas Y, Rudolph CD, ve ark. Pediatric GER Clinical Practice Guidelines (önceki NASPGHAN-ESPGHAN). J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2009;49(4):498-547.
4. Koletzko S, Niggemann B, ve ark. Diagnostic Approach and Management of Cow's Milk Protein Allergy in Infants and Children (ESPGHAN GI Committee). J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2012;55(2):221-229.

Uyarı: Bu belge çocuk gastroenteroloji uzmanları için klinik karar desteği amaçlıdır; hastaya özgü değerlendirmenin, güncel kılavuzların ve yerel ilaç ruhsat/dozaj bilgilerinin yerine geçmez. Dozlar hastanın yaşı,

kilosu, böbrek/karaciğer fonksiyonu ve komorbiditelerine göre bireyselleştirilmelidir.